

잠복결핵감염 치료, 3~9개월의 정확한 복용

잠복결핵감염 치료 — 약의 종류, 간 부작용, 함께 먹는 약 주의

짧은 치료로 결핵 발병 위험을 크게 낮춥니다

잠복결핵은 균이 잠든 상태 — 증상도 전염력도 없지만, 평생 5~10%는 활동성 결핵으로 진행합니다

예방 효과 60~90%

치료를 끝까지 마치면 활동성 결핵이 생길 위험이 60~90% 줄어듭니다. 위험이 0이 되는 것은 아닙니다.

3~9개월 복용

요법에 따라 3개월부터 9개월까지 매일 먹습니다. 몸 상태에 맞춰 의료진이 고릅니다.

본인부담 0%

건강보험 산정특례(V010)가 적용됩니다.



그림 · 약으로 잠든 균을 줄여 폐를 지키고, 의사와 함께 치료를 정하는 모습을 그린 설명용 그림입니다.

Tip · 잠복결핵 자체의 뜻과 검사는 '잠복결핵감염' 개요 자료에서 설명합니다.

근거 · 결핵 진료지침 5판(2024) · 세계보건기구 잠복결핵 지침 2020

국내에서 쓰는 세 가지 치료 요법

표준 치료는 리팜핀이 들어간 짧은 요법(4R·3HR)이고, 9H는 선택적으로 씁니다

	4R	3HR	9H
약	리팜핀	이소니아지드 + 리팜핀	이소니아지드
먹는 방법	매일 · 4개월 (120일)	매일 · 3개월	매일 · 9개월 (270일)
국내 권고	표준 치료	표준 치료	선택적으로 고려
끝까지 마친 비율	78.8%	—	63.2%
심한 간 부작용	0.3%	—	약 2.0%
다른 약과의 상호작용	많음 — 다른 약 효과를 떨어뜨림	많음 — 리팜핀이 들어 있음	적은 편

3HP는요? 리파펜틴을 쓰는 주 1회 요법(3HP)은 해외 권고 요법이지만, 국내에는 약이 도입되지 않아 쓸 수 없습니다.

Tip · 이름의 숫자는 개월 수, 글자는 약입니다(H 이소니아지드 · R 리팜핀). ‘—’는 이 자료에 비교 수치가 없다는 뜻입니다.

근거 · 결핵 진료지침 5판(2024) · Menzies D, NEJM 2018(4R·9H 비교)

치료에 쓰는 약 두 가지와 요법

작용·먹는 법·대표 부작용을 미리 알아 두면 안전하게 치료할 수 있습니다



01

이소니아지드

하루 1번 공복(식전 1시간·식후 2시간). 간 부작용과 손발 저림이 대표적이라 비타민 B6를 함께 먹습니다. 등푸른 생선·발효식품 뒤 얼굴이 붉어지고 두통이 날 수 있습니다.

300mg · B6 25~50mg



02

리팜핀

하루 1번 공복. 소변·눈물·땀·침이 주황~ 붉은색으로 변하는 것은 정상이며 약을 끊으면 사라집니다. 콘택트렌즈는 물들 수 있어 안경을 권합니다.

600mg · 제산제와 1시간 간격



03

요법 = 약의 조합

4R은 리팜핀만 4개월, 3HR은 이소니아지드와 리팜핀을 함께 3개월, 9H는 이소니아지드만 9개월 먹습니다. 간 기능·함께 먹는 약·임신 여부를 보고 고릅니다.

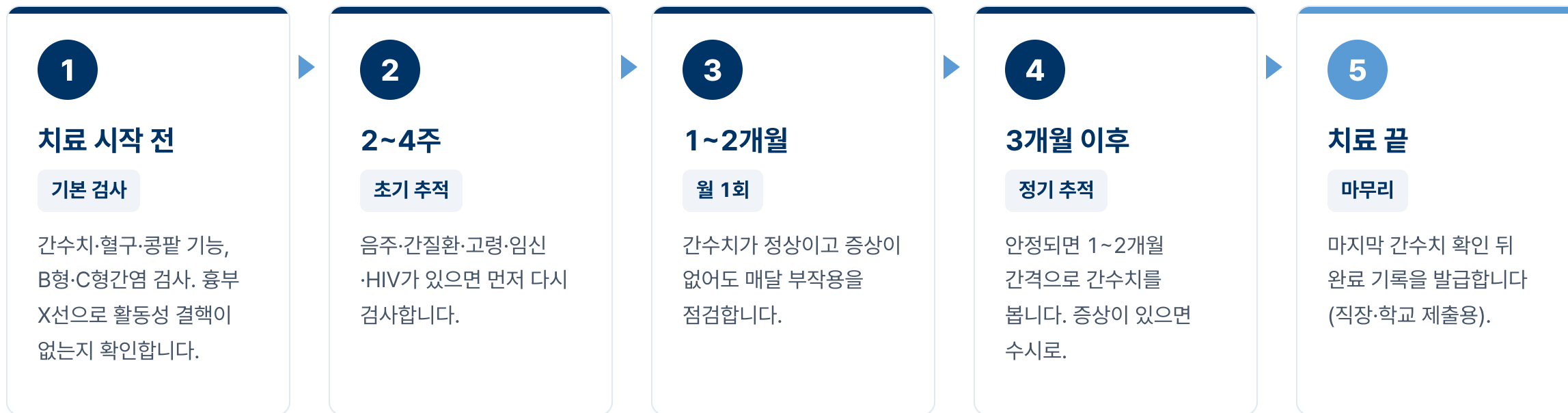
의료진과 함께 결정

Tip · 용량은 성인 기준입니다 — 실제 용량은 처방에 따릅니다.

근거 · 결핵 진료지침 5판(2024) · 미국흉부학회·질병통제예방센터 약물 자료

간 기능 혈액검사 일정

시작 전 기본 검사 뒤 정기적으로 추적합니다 — 증상 없는 간 부작용을 일찍 찾기 위해서입니다



약을 멈추는 기준 간수치가 정상 상한의 5배 이상(증상 없음) 또는 3배 이상(증상 있음)이면 약을 바로 멈춥니다.

Tip · '간수치'는 간세포가 다칠 때 올라가는 효소(AST·ALT) 수치입니다.

근거 · 미국흉부학회 간독성 성명 2006 · 결핵 진료지침 5판(2024)

간 부작용 위험이 높은 분들

하나라도 해당되면 더 자주 검사하고 더 꼼꼼히 살핍니다

- 1 65세 이상 고령**
 9H에서 간 부작용이 늘어 가능하면 짧은 요법(4R·3HR)을 권합니다.
- 2 만성 간질환 · B/C형간염 2~3배**
 치료 전 간염 검사를 하고, 간경변은 전문의와 상의합니다.
- 3 매일 음주 약 4배**
 치료 중 금주가 원칙 — 어렵다면 알려 주세요.
- 4 간에 부담 주는 약 병용**
 고용량 해열진통제·메토크레티드 등 모든 약을 알려 주세요.
- 5 임신 · 출산 뒤 3개월 주의**
 이 시기 이소니아지드 간 부작용이 늘어납니다.
- 6 영양 부족 · 저체중 주의**
 필요하면 영양 상담을 함께 합니다.

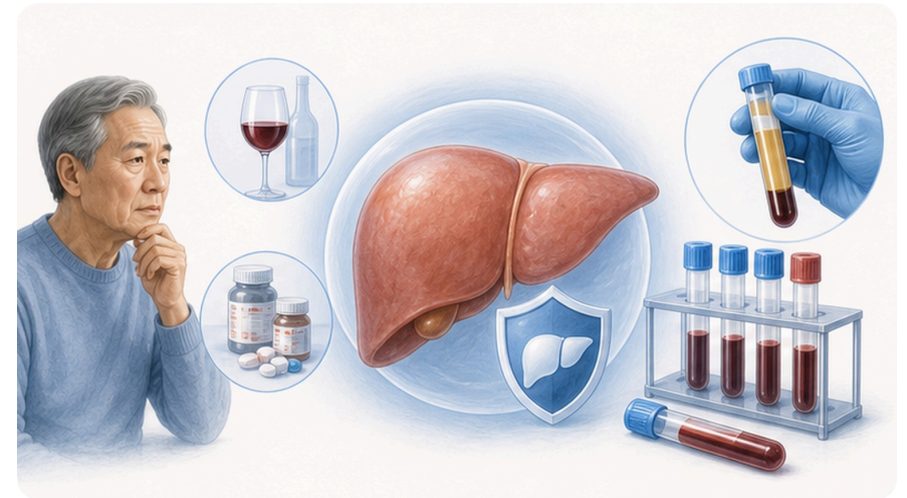


그림 · 나이·음주·함께 먹는 약이 간 부담을 키우고, 혈액검사로 살핍니다(설명용 그림).

Tip · 가끔 마시는 술도 위험을 약 2배로 높입니다 — 치료 기간엔 금주하세요.

근거 · 미국흉부학회 간독성 성명 2006 · 미국 공중보건국 감시 연구

이런 증상이 나타나면 약을 멈추세요

간 손상의 경고 신호 — 하나라도 있으면 약을 멈추고 같은 날 진료받으세요



그림 · 노란 눈 · 심한 피로 · 윗배 통증 · 진한 소변이 보이면 병원에 바로 연락합니다(설명용 그림).

황달 · 콜라색 소변

피부·눈 흰자가 노래지거나 콜라색 소변이면 멈춥니다(리팜핀의 주황색 소변과 다름).

구역·구토 · 윗배 통증 · 심한 피로

하루 넘게 음식이 안 받거나, 오른쪽 윗배가 아프고 평소와 다르게 기운이 없거나, 대변이 회색빛이면 간 부작용일 수 있습니다.

발진 · 고열 · 림프샘 부음

심한 약물 알레르기일 수 있어 약을 멈추고 응급 진료를 받습니다.

Tip · 증상이 있을 때 스스로 판단해 약을 다시 시작하지 마세요.

근거 · 미국홍부학회 간독성 성명 2006 · 미국 질병통제예방센터 잠복결핵 부작용 자료

리팜핀과 함께 먹을 때 주의할 약

리팜핀은 간에서 다른 약을 빨리 없애 효과를 떨어뜨립니다 — 먹는 약을 모두 알려 주세요

약	무엇이 달라지나	어떻게 하나
먹는 피임약	효과 64~66% 감소	콘돔·구리 자궁내장치 등으로 — 치료 끝난 뒤 4주까지
와파린 · 항응고제	피가 묽어지는 정도가 바뀜	1~2주 간격 혈액검사로 용량 조절
혈압약(칼슘차단제)	혈압 조절이 약해짐	다른 계열로 바꾸거나 용량 조절
고지혈증약(스타틴)	효과 80~87% 감소	잠시 멈추거나 영향이 적은 약으로
당뇨약(설폰닐유레아)	혈당이 오를 수 있음	혈당을 더 자주 재고 필요하면 보완
면역억제제 · 일부 항진균제·HIV 약	약 농도가 크게 떨어짐	함께 쓰지 않거나 상급병원 의뢰

Tip · 한약·건강기능식품도 빠짐없이 알려 주세요.

근거 · 리팜핀 약물상호작용 자료(Lexicomp 2024)

임신·모유 수유 중에는 이렇게 정합니다

치료 시기와 약은 위험과 이익을 따져 의료진과 함께 정합니다



그림 · 임신·수유 중에도 의사와 상의해 치료 시기와 약을 함께 정하는 모습을 그린 설명용 그림입니다.

Tip · 이소니아지드를 먹는 동안은 비타민 B6를 꼭 함께 먹습니다.

출산 뒤로 미룰 수 있는 경우

임신 중 새로 알게 된 저위험군 — 최근 결핵 환자 접촉이 없고 면역이 정상이면 대개 출산 뒤 2~3개월까지 미룹니다. 그동안 간수치만 추적합니다.

임신 중에도 치료하는 경우

최근 결핵 환자와 밀접 접촉, HIV·면역억제제 복용, 2년 안에 혈액 검사가 음성에서 양성으로 바뀐 경우. 9H나 4R을 우선합니다.

모유 수유

모유 수유 중에도 이소니아지드·리팜핀을 쓸 수 있습니다(비타민 B6 필수). 출산 뒤 3개월 안에는 간수치를 더 자주 봅니다.

근거 · 미국 질병통제예방센터 임신 중 결핵 권고 · 세계보건기구 잠복결핵 지침 2020

상급병원·전문의와 함께 봐야 하는 경우

아래 네 상황은 동네 의원 단독보다 전문의 협진을 권합니다

간경변 · 활동성 B·C형간염

약 선택과 검사를 더 촘촘히 해야 합니다. 소화기·감염내과와 상의하며, 4R이 상대적으로 안전할 수 있지만 개별 평가가 필요합니다.

HIV 감염 · 장기이식 후

HIV 약·면역억제제와 리팜핀의 상호작용이 복잡합니다. 감염내과 협진 뒤 약과 일정을 정합니다.

활동성 결핵이 의심될 때

치료 중 새 기침·열·체중 감소·밤 식은땀이 생기면 X선·가래 검사로 다시 봅니다. 잠복결핵 약만으로 치료하면 내성 결핵 위험이 있습니다.

중단 · 부작용이 반복될 때

부작용으로 멈췄거나 2개월 넘게 복용을 놓친 경우, 내성 결핵 환자 접촉이 의심될 때는 결핵·감염내과로 의뢰합니다.

Tip · 해당되는지 애매하면 치료 시작 전에 먼저 상의하세요.

근거 · 결핵 진료지침 5판(2024) · 세계보건기구 잠복결핵 관리 2020

오늘 꼭 기억할 핵심 여덟 가지

끝까지 정확히 먹는 것이 치료 성공의 핵심입니다

01 요법은 의료진이 정합니다 — 끝까지 완주가 핵심

02 약은 매일 1번 공복에 복용

03 황달·콜라색 소변·심한 피로 → 약 멈추고 같은 날 진료

04 치료 중 금주 — 매일 마시면 간 부작용 약 4배

05 리팜핀은 피임약·혈압약·당뇨약·와파린 효과를 낮춤

06 소변·눈물·땀의 주황색은 정상(렌즈 대신 안경)

07 먹는 약·건강기능식품·한약은 모두 알려 주세요

08 임신·간질환·HIV는 치료 전에 꼭 상담

Tip · 궁금한 점은 언제든지 물어보세요 — 끝까지 마치는 것이 가장 중요합니다.

근거 · 결핵 진료지침 5판(2024)

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

잠복결핵감염 치료를 시작하거나 권유받은 분을 위한 설명자료입니다. 요법과 기간은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

결핵 진료지침 5판(2024) · 세계보건기구 잠복결핵 지침 2020 · Menzies D, NEJM 2018 · 미국흉부학회 간독성 성명 2006



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요